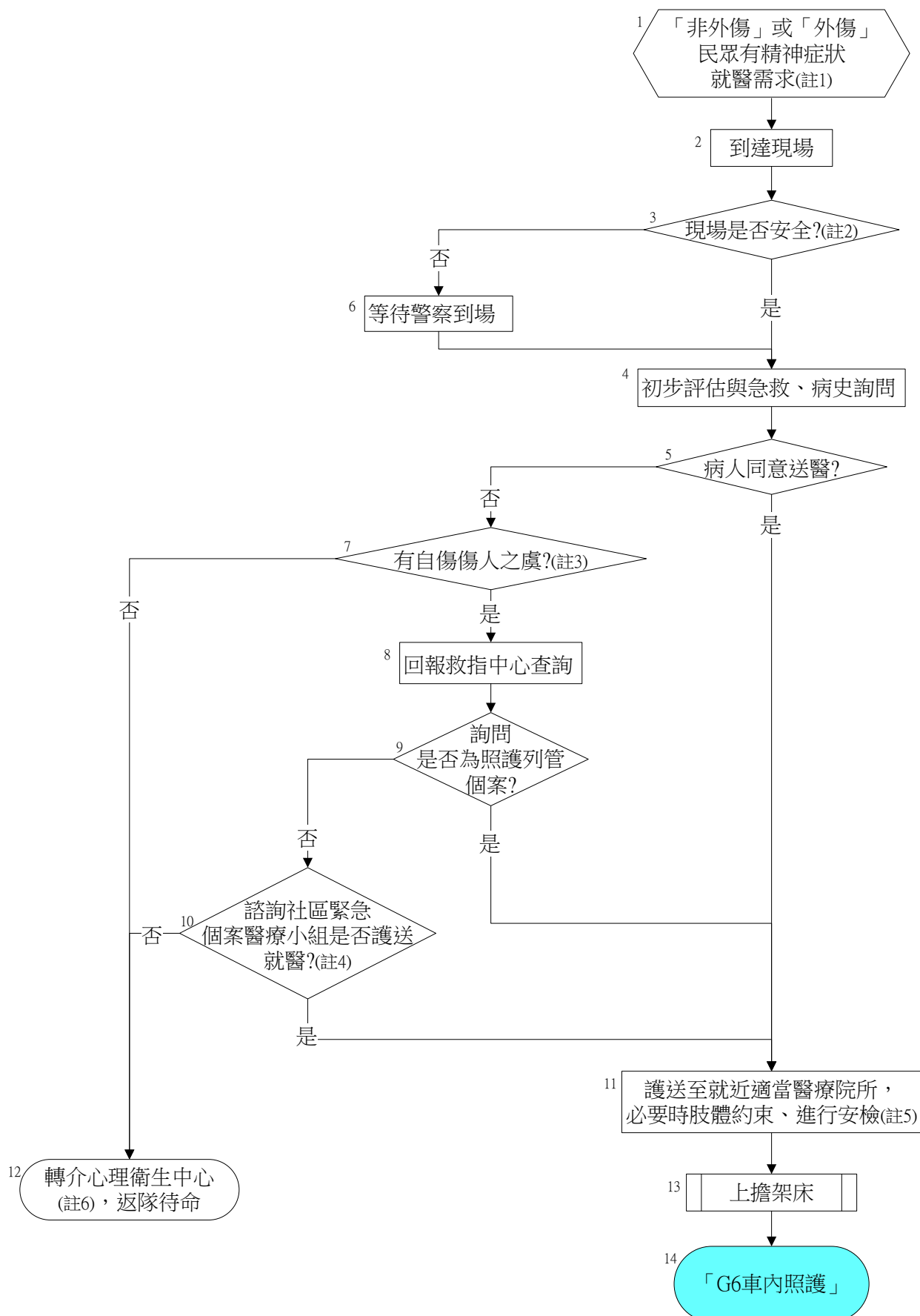


S9 精神異常/行為急症病人救護

程 序



要 旨

- 一、本流程適用於精神衛生法第三條第一款所描述之狀態，包含疑似精神疾病之人，或因內、外科問題所引發之精神症狀之人。
- 二、處理行為急症病人（酒醉、鬥毆、自殺、藥物濫用、精神疾患等）的第一要務，是注意自身安全，不要遭到病人的攻擊。例如接觸有潛在暴力傾向的病人時，務必要求警察戒護、與病人保持一定距離、不要站在死角、評估病人簡短快速並保持防備等。
- 三、要防止行為急症病人再次受傷。例如將危險物品（如尖銳物、易燃物如打火機、毒藥物）收拾好、不要讓病人有機會獨處等。
- 四、不要在言語上責備或激怒病人，因為言語衝突是攻擊行為的前兆。

註 解

註1>

- 一、所謂精神病人指依精神衛生法第3條所稱病人及所定狀態：
 - （一）精神疾病：指思考、情緒、知覺、認知、行為等精神狀態表現異常，致其適應生活之功能發生障礙，需給予醫療及照顧之疾病；其範圍包括精神病、精神官能症、酒癮、藥癮及其他經中央主管機關認定之精神疾病，但不包括反社會人格違常者。
 - （二）病人：指罹患精神疾病之人。
 - （三）嚴重病人：指病人呈現出與現實脫節之怪異思想及奇特行為，致不能處理自己事務，經專科醫師診斷認定者。
- 二、依據派遣內容，可考慮攜帶防刺背心及防割手套出勤。
- 三、執行其他類型救護過程中，若病人為精神病人或疑似第三條第一項第一款所定狀態之人，亦需同時參考本流程。

註2>

確認現場是否安全，可用精神危機之初評、次評進行風險管理：

一、初級評估：叫叫CABD

透過認知(C)、情緒(A)、行為(B)的評估，可以快速評估暴力風險。人的思緒會表現在言語上，若語無倫次、注意力渙散，就表示可能有認知上的問題；情緒則表現在表情與肢體，例如說話音量大、目露凶光、不尋常的安靜或暴躁；風險行為包括來回踱步、靜坐不能、突然停止動作等。如果病患無法言語對接，或情緒高漲處於危機階

段，或是有立即危險行為的病患，應開始規劃保護性約束的計畫。評估的同時需隨時運用團隊資源，與現場夥伴進行現場溝通，並預定好替代方案。

叫	叫團隊	聯絡警察與衛生單位
叫	叫周邊、叫裝備	確認環境淨空、管理圍觀者、確認防護裝備充足
C	認知(Cognition)	確認病患是否思想怪異、脫離現實
A	情緒(Affection)	評估病患情緒是否高張、憤怒、焦躁、恐懼、害怕等
B	行為(Behavior)	評估是否有異常舉動或立即的危險行為
D	決定壓制或降階 (Decide and Defuse)	進行言語降階，或是保護性約束

二、次級評估：居安思危、枕戈待旦

若初評發現沒有立即危險，可進行精神危機的次級評估，口訣是「居安思危、枕戈待旦」，這八個項目在操作上沒有一定的順序。次級評估可用於完整的資訊蒐集、判斷是否需要護送就醫、資訊交接，以及確保護送就醫流程的安全。

居	居住環境是否有空間可介入與撤離	枕(診)	病患有無過去精神病診斷病史
安	確保現場和周邊的個人安全	戈	病患是否持有 武器 或有藥物濫用
思	評估是否 思想怪異 和急性精神症狀	待	病患如何對待重要關係人
危	若感覺 危險 應相信直覺	旦	一旦 現場升溫應擬定緊急計畫

註3>

精神病人或疑似精神病人是否有傷害他人或自己或有傷害之虞，應由警察、衛生及消防共同認定。「自傷、傷人之虞」之判斷可藉由家屬、旁人描述之客觀事實，使用衛福部建議之「精神病人高風險檢傷評估量表」評估風險。如果總分大於等於八分，則建議啟動護送就醫流程。

評分 A：危險性= 分	
5	清楚表現或幻覺(聽到命令)出現有自殺或殺人的念頭，或在這次發病期，已經有過一次認真的嘗試，存在難以預測、衝動、暴力的行為表現。
4	表現或幻覺(聽到命令)出現有自殺或殺人的念頭，這念頭並不是很堅定，或這些對應行為多少因環境壓力才起。過去曾有暴力或衝動行為，但是目前沒有這些徵兆。
3	表現出有自殺或殺人的念頭，但猶豫不決，或只出現無效的作態行為，對衝動的控制能力仍有疑問。
2	出現一些自殺或殺人的念頭或行為，或者曾經有過，但顯然希望能夠控制，且有能力控制這些行為。
1	沒有自殺或殺人的念頭或行為。過去亦沒有暴力或者衝動行為的紀錄。
評分 B：支持系統= 分	
5	沒有家人、朋友或其他的人。所待機構沒有辦法提供所需的立即支持。
4	有一些可利用的支持系統，但是效果可能是有限的。
3	有潛在可用的支持系統，但是動員它們有明顯的困難。
2	有關心的家人、朋友或其他人，但在提供所需的支持的能力或意願上，仍有些問題存在。
1	有關心的家人、朋友或其他人，而且有能力跟意願提供需要的支持。
評分 C：合作的能力= 分	
5	無法合作，或出現強烈的拒絕。
4	對於別人為個案所做的努力，表現出一點也不感興趣或不理解。
3	對所提供的治療措施能被動接受。
2	想要被幫助但是猶疑不決，或者動機不強。
1	主動尋求治療，願意且有能力合作。
量表總分：A+B+C = 分	
量表： ☐ ≥ 8 分 立即送醫 總分 ☐ 5-7 分 門診或居家治療或社區精神病人照護優化計畫 ☐ 3-4 分 公衛護理師或關訪員或心理衛生社工訪視	

註4>

(臺北市府衛生局101年3月20日北市衛醫護字第10130468600號函)

- 一、當病患有自傷傷人之虞，需違反其意願護送就醫時，需儘可能取得病人姓名及身分證號後洽請本局救災救護指揮中心(簡稱：救指中心)向本府衛生局查詢是否為列管個案。
- 二、於執行送醫有疑義或爭議時，洽請本局救指中心諮詢「社區緊急個案醫療小組」，救指中心依下表所示，致電表明『請找社區緊急個案醫療小組人員』請求現場評估或提供電話諮詢。
- 三、臺北市社區緊急個案醫療小組諮詢及啟動專線：

行政區		查詢精神照護個案			緊急個案醫療小組諮詢		
		日間：9 時至 17 時		夜間： 17 時至翌日 8 時			
		健康服務中心	衛生局				
北區	士林區	(02) 2881-3039	1999 分機 1892-1893	EMOC：028786-3120(21)	三軍總醫院北投分院 電話：02-28962095 或 0965813818		
	北投區	(02) 2826-1026					
	大同區	(02) 2585-3227					
	中山區	(02) 2501-4616					
	萬華區	(02) 2303-3092					
	中正區	(02) 2821-5158					
南區	信義區	(02) 2723-4598					臺北市立聯合醫院松德院區 電話：2726-3141 轉 1266
	大安區	(02) 2733-5831					
	文山區	(02) 2234-3501					
	南港區	(02) 2782-5220					
	內湖區	(02) 2791-1162					
	松山區	(02) 2767-1757					

註5>

- 一、依據精神衛生法第48條第3項暨指定精神醫療機構管理辦法規定，本市指定精神醫療機構名單：(依臺北市府衛生局最新公告之本市指定精神醫療機構名單)。
 - 二、依本府緊急醫療救護諮詢委員會100年度第1次會議決議，有關本市精神病人119送醫流程如下：(摘錄自臺北市府100年2月23日府衛醫護字第10030185701號函)
- (一) 依據精神衛生法第 48 條規定，被護送就醫之人應經醫療機構適當處置後，診斷屬

病人者，應轉送至地方主管機關指定之精神醫療機構繼續接受治療。

(二) 警消人員對於疑似精神病人緊急醫療之處理程序：

- 1、具內外科合併症或其餘特殊生理狀況者，將優先就近送至本市急救責任醫院急診，進行醫療處置。
 - (1) 非外傷合併症包含意識不清（例如：遭路人通報路倒）、毒物不明氣體（例如：燒炭、一氧化碳）或藥物中毒或過量、傳染性疾病（例如：疥瘡、麻疹、新冠肺炎、流行性感冒等）、疑似腦中風、缺血性胸痛、異物梗塞、腹痛、腸胃道出血等內科主訴。
 - (2) 外傷合併症包含無法止血或止血困難之傷口、外觀可見明顯超過 1 公分以上撕裂傷、動物咬傷的傷口、燒燙傷、頭部外傷（例如：耳漏、鼻漏、熊貓眼等顱底骨折或顱內出血之徵候）等外傷病患。
 - (3) 特殊生理狀況包含已知懷孕或生理女性明顯腹部隆起（不同於腹部脂肪堆積）等。
- 2、未併有外(非)傷急重症者，則直接護送至本市精神專科醫院(本市市立聯合醫院松德院區及三軍總醫院北投醫院)。
- 3、如無法判斷時，可經由衛生局啟動「社區緊急個案醫療小組」出勤。

(三) 當指定精神醫療機構（兼具急救責任醫院者）無法提供床位或後續適當處置時，應依據院際間轉診（院）流程，轉送其他「本市指定精神醫療機構」。

三、當符合精神衛生法第48條要件送醫時，得不受病歷所在醫院之限制，護送前往本市指定精神醫療機構。

注意事項：

- 一、當精神病人或疑似精神病人合併有傷害風險（有傷害他人或自己或有傷害之虞）時，因有傷害風險且為救護之，可依警察依警察職權行使法第19條規定進行管束，或依精神衛生法第48條第5項救護人員可協同執勤員警使用約束帶。惟為避免紛爭，請務必與現場家屬或保護人等相關人員適當說明。
- 二、行政機關為避免危害之發生得依行政執行法第36、37條進行即時強制，惟針對有傷害風險之精神病人護送送醫乙節，警察人員配有槍械、防彈衣、警銬及其他核定之戒具（如防暴網）等，且於法源依據部分，除精神衛生法第48條及依行政執行法第36、37條外，另依警察職權行使法第3、4、7、19、20、26、28 條規定得執行必要之管束，實務上如有強制送醫治療需求個案，由警察單位依內政部警政署頒訂之警察機關分駐(派出)所常用勤務執行政程序彙編（簡稱：警察執行政程序彙編）/保安類/護送精神病患就醫作業程序辦理，本局救護人員可依衛生福利部頒布之「執行精神疾病病人拘束身體

或限制行動自由處置辦法」進行保護性約束並會同護送就醫。

- 三、對病患進行保護性約束時，應符合本局「緊急醫療救護單項技術操作規範」之「約束流程」為之。
- 四、護送就醫時，因安全考量，應請警察同仁協助進行安檢，並於救護車內陪同戒護到院。
- 五、本局同仁在執行傷病患送醫前，務必請傷病患家屬或協同處理人員於救護紀錄表簽名；並應填具「臺北市通報『社區緊急醫療小組』、協助或護送社區嚴重精神疾病病人或疑似精神疾病病人醫療服務單」。

註6>

- 一、向家屬及通報單位說明本局可協助照護範圍，若無緊急醫療需求，應提供本市12區健康服務中心連繫窗口之電話，以提供家屬衛教協助。
各區社區心理衛生中心，聯絡電話：
萬華區：(02)2303-3611、
文山區：(02)8661-5387、
北投區：(02)2821-2060、
信義區：(02)-2763-0668
南港區：(02)2651-5501
- 二、若經同仁判斷或經諮詢後不符合護送就醫要件，請家屬簽名返隊後，需填寫「臺北市社區疑似精神疾病個案轉介單」。
- 三、一般民眾干擾社區之問題宜由警察逕依社會秩序維護法等規定處理。
- 四、必要時由健康服務中心邀集警察、里長、家屬等，透過協調會方式共同討論積極處理作為。